

Ви - лікар-педіатр. У відділенні інтенсивної терапії інфекційного стаціонару знаходиться дитина 5 років з тяжкою формою менінгіту, порушенням свідомості. Для годування дитини проведіть назогастральне зондування.

Робоче місце здобувача освіти

Перед входом на станцію повинно бути розташоване клінічне завдання (брифінг).

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря-педіатра обов'язково повинно включати:

№ з/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл маніпуляційний	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
Перелік медичного обладнання (багаторазового використання)		
1	Ємкість для марлевих кульок	1 шт.
2	Контейнер для зборі відходів класу А (класу В)	1 шт.
3	Пінцет	1 шт.
4	Медичний лоток	1 шт.
5	Лейкопластир	1 шт.
6	Ножиці	1 шт.
7	Стерильна вазелінова олія	1 шт.

№ з/п	Перелік медичного обладнання (одноразове використання)	Кількість на 1 спробу
1	Марлеві кульки для обробки шкіри рук	1шт
2	Стерильні гумові рукавички	1шт
3	Назогастральний зонд	1шт
4	Шприц Жане	1шт
5	Заглушка для зонда	1шт
6	Стерильна пелюшка	1шт
Перелік медичного обладнання (симуляційне обладнання)		
1	Манекен дитини для проведення назогастрального зондування (Програмування не передбачено сценарієм)	1 шт.



Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Коректне розташування пацієнт-лікар (стоячи навпроти пацієнта), позначити свою роль.	Сказати Доброго дня. Я лікар педіатр - буду проводити назогастральне зондування для годування дитини.
1.2	Інформуємо матір, що дитині буде проведено назогастральне зондування для годування дитини, отримуємо згоду	Сказати Дасте згоду на цю маніпуляцію? Будемо вважати, що руки оброблені

2. Виконання навички		
2.1	Обробити руки та вдягнути захисну маску та рукавички. Коректне (лежачи на боку) розташування пацієнта на столі.	Виконати/сказати Дитину вкладаємо на бік на маніпуляційному столі.
2.2	Визначити відстань, на яку слід ввести зонд (відстань від крила носа до мочки вуха – зробити першу мітку, від мочки вуха до мечоподібного відростка другу мітку). Прикрити груди пацієнта стерильною пелюшкою.	Виконати/Сказати «Визначаю відстань, на яку слід ввести зонд - від крила носа до мочки вуха – роблю першу мітку, від мочки вуха до мечоподібного відростка - другу мітку). Прикриваю груди пацієнта стерильною пелюшкою»
2.3	Провести місцеву анестезію порожнини носа та глотки спреєм 10% лідокаїну. Нанести на кінець зонда стерильне масло.	Виконати/Сказати «Проводжу місцеву анестезію порожнини носа та глотки спреєм 10% лідокаїну. Наношу на кінець зонда стерильне масло».
2.4	Запрокинути голову пацієнта та ввести зонд через нижній носовий хід на відстань до першої мітки. Повільно просувати зонд до другої мітки.	Виконати/Сказати «Запрокидную голову пацієнта та ввожу зонд через нижній носовий хід на відстань до першої мітки. Повільно просуваю зонд до другої мітки.»
2.5	Переконавшись в правильному розташуванні зонда в шлунку – ввести з допомогою шприця Жане близько 20 мл повітря, вислуховуючи його в епігастральній ділянці. (або при аспірації шприцем Жане в зонд повинен надходити вміст шлунка (вода і шлунковий сік).	Виконати/Сказати «Вводжу за допомогою шприця Жане близько 20 мл повітря, вислуховуючи його в епігастральній ділянці для визначення локалізації зонда. (або при аспірації шприцем Жане в зонд повинен надходити вміст шлунка».
2.6	Зафіксувати зонд до спинки носа лейкопластирем. Закрити зонд заглушкою.	Виконати/Сказати «Фіксую зонд до спинки носа лейкопластирем. Закриваю зонд заглушкою.».
3. Діагностика (встановити попередній діагноз)		
Провести інтерпретацію встановлення назогастрального зонду для годування.		Сказати «За попереднім оглядом – стан дитини стабільний» (Будемо вважати – встановлення назогастрального зонду пройшло без ускладнень)
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Динамічний нагляд за пацієнтом.	Сказати «Проводимо зондове годування дитини до відновлення свідомості, регулярно контролюємо його знаходження в шлунку,

		промиваємо водою».
4.2	Визначити подальший маршрут пацієнта	Сказати «При відновленні свідомості – видаляємо зонд, переводимо дитину на оральне годування»